

MÉTODO

- Umbral de Hb sin ajuste real por altitud (formulas genericas)
- Ausencia de protocolo digital estandarizado de tamizaje
- Falta de consejeria nutricional estructurada posterior

MEDICIÓN

- HemoCue: invasivo, doloroso, acceso logistico limitado
- Subregistro epidemiologico por fragmentacion de sistemas
- Falta de trazabilidad auditable (sin FHIR Provenance/AuditEvent)
- Resultados no georreferenciados, sin analitica espacial

MANO DE OBRA

- Alta rotacion de personal (regimen SERUMS)
- Capacitacion discontinua entre relevos
- Sobrecarga de funciones en puestos unipersonales

MEDIO AMBIENTE Y MATERIALES

- Altitud extrema (~3,800 m s.n.m.) con efecto real sobre la Hb
- Conectividad/electricidad intermitente en zona rural
- Dispersion geografica que encarece la logistica
- Quiebres de stock de insumos HemoCue

GESTIÓN

- Sistemas de informacion fragmentados (HIS, SIEN, Padron Nominal)
- Bajo gobierno de datos y ciberseguridad (Ley 29733)
- Ausencia de analitica geoespacial para priorizar recursos

PROBLEMA CENTRAL:
Tamizaje de anemia infantil impreciso, invasivo, no trazable y con riesgo de sobre/subdiagnostico por altitud

